

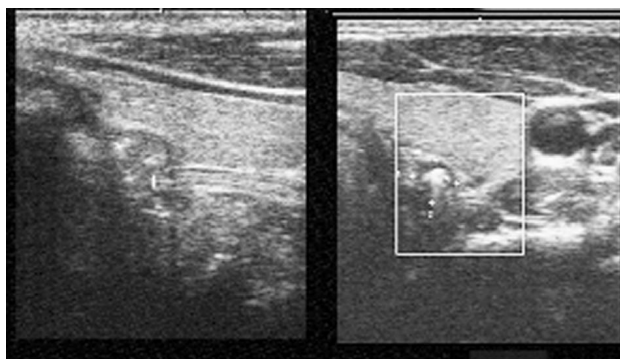


图3 食管憩室: 甲状腺左侧叶后方见一混合回声团块, 边界清晰, 内见闪烁伪像, 纵断面于食管相连

2.2.5 食管炎 4例食管炎超声表现为食管壁稍增厚, 黏膜毛糙, 层次欠清晰, 回声增强, 食管腔内可见斑片状强回声及不规则积液。

3 讨论

以往食管疾病的诊断多靠X线钡餐或内窥镜检查, X线检查简便, 易了解病灶长度食管狭窄程度及管壁的蠕动情况, 但易受钡剂用量、充盈程度、钡剂重力等影响而导致假阴性, 且对人体有放射性损害。纤维食管镜应用较广泛, 其与组织细胞活检相结合, 是食管疾病理想的检查诊断方式。但该方式患者较痛苦, 年老体弱者难以接受, 同时对食管周围组织的情况无法显示。而高频彩色多普勒超声可以弥补其不足。

颈段食管癌在各段食管癌发生率中最低, 本组37例被检出, 并经X线钡餐或内镜手术证实, 其诊断准确率100%。超声图像显示不规则增厚的食管壁, 层次结构不规则, 有中断现象, 内腔变窄, 有强回声的食物残渣附着。彩色多普勒超声检查可判断肿瘤浸润的层次和深度, 了解食管周

围有无淋巴结转移, 为指导外科手术切除可能性及分期提供帮助。

食管憩室以咽食管连接部最多发, 多发生于环咽肌上方, 咽食管连接部后壁, 属于常见病^[3]。高频超声不仅能够清晰显示憩室的大小、形态、内部回声、彩色多普勒的闪烁伪像, 还能判断憩室壁的情况及与周边组织的关系, 为临床提供更多的诊断价值及治疗依据^[4-5], 值得注意的是食管憩室有恶变倾向, 检查中要注意憩室内壁情况。

高频超声对于食管中小息肉、溃疡、炎症的诊断有一定的局限性, 应根据具体情况合理选择检查。

笔者认为, 颈段食管疾病往往是在检查甲状腺时被发现, 发现问题时, 嘱患者多次吞咽或多次饮水或饮胃肠造影剂, 仔细观察其内部情况均能确诊。故高频超声是诊断颈段食管疾病的一种简便、无创的检查方法。

参 考 文 献

- [1] 陈敏华, 朱强, 严昆. 体表超声对腹部食管病变及早期癌的诊断价值[J]. 中华医学杂志, 1998, 78 (1): 44.
- [2] 程瑞萍, 张利平, 侯晓斌, 等. 二维、彩色多普勒血流显像在腹段食管癌诊断及分型中的应用[J]. 西北国防医学杂志, 2008, 29 (6): 433.
- [3] 王文胜, 马德茂, 李哲, 等. 食管憩室的临床特点及治疗 (附65例临床分析)[J]. 陕西医学杂志, 2009, 38 (2): 211.
- [4] 孙建刚, 钱彩艳, 夏国园. 超声诊断咽食管憩室1例[J]. 实用肿瘤杂志, 2012, 27 (5): 45.
- [5] 王其彰. 食管外科[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2005: 483.

(收稿: 2013-12-14 修回: 2014-04-28)

(发稿编辑: 阳 光)

什么是药物相互作用？

药物相互作用, 即药物与药物之间的相互作用, 是指一种药物改变了同时服用的另一种药物的药理效应。其结果是一种药物的效应加强或削弱, 也可能导致两种药物的效应同时加强或削弱。药物相互作用可分为两类: ①药代学的相互作用, 是指一种药物改变了另一种药的吸收、分布或代谢。例如, 抗酸药中的 Ca^{2+} 离子, 与四环素螯合, 这种螯合物不能补吸收, 从而影响了四环素的吸收, 影响了疗效。再如, 阿司咪唑由 CYP3A4 酶代谢, 酮康唑是 CYP3A4 的抑制剂, 当两者同时服用时, 由于代谢酶被抑制, 阿司咪唑的代谢受阻, 使血药浓度升高, 而引起不良反应。②药效学的相互作用, 是指激动剂和拮抗剂在器受体部位的相互作用。